

DIM Centros de Salud: análisis de situación y oportunidades de automatización inteligente

Diagnóstico del recorrido del paciente y seis propuestas de mejora basadas en automatización (n8n) e inteligencia artificial, priorizadas por impacto y esfuerzo.

Preparado por: Martín Fisher **Fecha:** Julio 2026 **Alcance:** análisis sobre información pública

RESUMEN EJECUTIVO

La oportunidad en una página

DIM es una institución líder de la zona oeste con más de 60 años de trayectoria, 16 centros y una apuesta digital real: app propia, portal de pacientes, WhatsApp oficial y resultados online. La base tecnológica ya existe. La oportunidad está en la **capa de orquestación**: los canales y sistemas actuales no siempre conversan entre sí, y eso genera fricciones visibles para el paciente (esperas en WhatsApp, turnos sin disponibilidad online, demoras en resultados) y costo operativo interno (call center saturado, reprocesos, reclamos).

Tesis: sin reemplazar ningún sistema existente, una capa de automatización con n8n + agentes de IA puede conectar turnero, laboratorio, WhatsApp y back-office para que cada evento (un turno liberado, un informe firmado, una receta solicitada) dispare la acción correcta sin intervención manual. Primeros resultados medibles en 30–45 días, medidos en ausentismo, tiempo de primera respuesta y % de gestiones resueltas sin operador.

CONTEXTO

1. La institución, en números públicos

DIMENSIÓN	DATO
Trayectoria	Fundada en 1964 en Ramos Mejía por el Dr. José María Paz (DIRM S.A.); hoy referente de la zona oeste.
Escala	16 centros (Ramos Mejía, Morón, Liniers, Caballito, Once) · +500 profesionales · baja a alta complejidad.
Servicios	Consultas, imágenes, laboratorio (extracciones a domicilio), odontología, cirugías, demanda espontánea; nueva Onco Fleming.
Financiadores	PAMI (libre elección), IOMA, IOSFA, ASI, AMFFA y convenios institucionales, entre otros.
Canales digitales	App DIM SALUD (turnos, resultados, recetas, certificados) · portal con chat 24 hs · WhatsApp oficial con asistente v
Comunidad	~50.000 seguidores en Instagram · +70.000 en Facebook · ~19.500 en LinkedIn · Fundación DIM · sede UBA de resi

La lectura importante: DIM ya decidió ser una institución digital — su lema en redes es *“Te cuidamos hoy, con la tecnología del mañana”*. Este documento propone el siguiente paso natural de esa decisión.

DIAGNÓSTICO

2. Fricciones detectadas en el recorrido del paciente

Relevé señales públicas (reseñas de la app, plataformas de reclamos, redes) y las ordené por etapa del recorrido. Son hipótesis de trabajo a validar con el equipo — los puntos donde el paciente hoy percibe fricción y la automatización tiene

más para aportar:

- 01 WhatsApp que deriva sin cerrar el ciclo:** el asistente virtual toma el contacto pero la derivación a operador queda horas sin respuesta; el paciente reintenta por teléfono o va a la sede — el mismo caso cuesta tres veces.
- 02 Disponibilidad online que no refleja la capacidad real:** especialidades como ecografía o ginecología sin turnos visibles en el canal digital pese a ofrecerse en varios centros; bugs puntuales de la app al seleccionar turno.
- 03 Cancelaciones sin aviso y ausentismo sin gestión:** reclamos por turnos cancelados sin notificar; del otro lado, el no-show sin confirmación activa ronda el 20–30% en el sector.
- 04 Resultados que el paciente persigue:** los resultados están online (fortaleza real), pero hay reclamos por demoras y estudios que no aparecen — falta el aviso proactivo y el control interno de plazos.
- 05 Recetas y autorizaciones sin estado visible:** solicitudes de receta digital sin respuesta; cada “¿cómo va mi pedido?” vuelve a cargar el call center.
- 06 Información inconsistente entre canales:** call center, sedes y chat responden distinto sobre coberturas, preparaciones y horarios — cada canal usa su propia fuente.
- 07 Reputación sin circuito de recupero:** la insatisfacción escala a plataformas públicas por casos que eran recuperables si alguien los detectaba a tiempo.

Patrón común: nada de esto es falta de sistemas — turnero, laboratorio, app y WhatsApp ya existen. Son **eventos que no viajan entre sistemas** y **ciclos que no cierran:** exactamente el problema que resuelve una capa de orquestación.

PRIORIZACIÓN

3. Seis iniciativas, por impacto y esfuerzo

#	INICIATIVA	FRICCIÓN	IMPACTO	ESFUERZO	HORIZONTE
P1	Confirmación inteligente de turnos + lista de espera	02 · 03	ALTO	Bajo	Sem. 3–6
P2	Base de conocimiento única (RAG) para todos los canales	06 · 01	ALTO	Bajo	Sem. 3–6
P3	Agente IA en WhatsApp con acceso real al turnero	01 · 02	ALTO	Medio	Sem. 7–10
P4	Entrega proactiva de resultados + control de SLA interno	04	ALTO	Medio	Sem. 7–10
P5	Circuito de recetas y autorizaciones con estado visible	05	MEDIO	Medio	Sem. 11–13
P6	Voz del paciente: encuestas, alertas y tablero operativo	07	MEDIO	Bajo	Sem. 11–13

Segunda ola (a validar): automatización de back-office (órdenes y autorizaciones de financiadores, digitalización de órdenes en papel, control de débitos) y onboarding automatizado de personal — dos áreas donde ya tengo proyectos implementados.

PROPUESTAS

4. Fichas de propuesta

P1 Confirmación inteligente de turnos y lista de espera automática

SOLUCIÓN Workflow n8n sobre la agenda: recordatorio por WhatsApp a las 48 y 24 hs con respuesta de un toque (confirmo / reprogramo / cancelo). Cada hueco liberado se reofrece automáticamente a la lista de espera; si un profesional cancela su agenda, sus pacientes reciben aviso y opciones en minutos.

IMPACTO Reducciones típicas del 30–50% del ausentismo; agenda más llena con la misma estructura; elimina la queja más sensible (cancelación sin aviso). *Métricas:* tasa de no-show, % de huecos reasignados.

P2 Base de conocimiento única con IA (RAG) para todos los canales

SOLUCIÓN Consolidar el contenido que ya existe (preparaciones de estudios, cartilla, horarios, requisitos por financiador) en una base única consultada por IA: el mismo motor responde al asistente de WhatsApp, al chat del portal y a una consola interna para operadores.

IMPACTO Respuesta consistente en todos los canales; operadores nuevos productivos en días; menos recontactos por información errónea. *Métricas: precisión auditada, tiempo medio de atención.*

P3 Agente de IA en WhatsApp con acceso real al turnero

SOLUCIÓN Agente conversacional (Claude) orquestado con n8n sobre la API de WhatsApp Business, con herramientas conectadas al turnero: consulta disponibilidad real, reserva, reprograma, cancela e informa preparaciones. Deriva a humano solo lo necesario, con cola priorizada, SLA visible y contexto completo para el operador.

IMPACTO Atención 24/7 real; resolución sin operador de la mayoría de las gestiones (benchmark: 60–80%); descompresión inmediata del call center. *Métricas: % resuelto sin humano, tiempo de primera respuesta.*

P4 Entrega proactiva de resultados y control interno de demoras

SOLUCIÓN Cuando el informe se firma en laboratorio/imágenes, n8n notifica al paciente por WhatsApp con acceso seguro. En paralelo, un monitor interno alerta al sector cuando un estudio supera su plazo: la demora se gestiona antes de que el paciente la sufra.

IMPACTO Menos llamadas de consulta de estado; demoras detectadas internamente y no en redes. *Métricas: tiempo informe firmado → paciente notificado, estudios fuera de SLA.*

P5 Circuito de recetas y autorizaciones con estado visible

SOLUCIÓN Intake estructurado (app/WhatsApp) con validación automática de datos y cobertura, ruteo al profesional correcto, recordatorios internos por SLA y notificación al paciente en cada cambio de estado: recibido, en revisión, emitida, rechazada con motivo.

IMPACTO Cierra un ciclo hoy abierto; elimina una fuente completa de reclamos y llamadas. *Métricas: tiempo de ciclo, % de solicitudes vencidas de SLA.*

P6 Voz del paciente: encuestas post-atención, alertas y tablero

SOLUCIÓN Encuesta breve automática post-atención por WhatsApp; análisis de sentimiento con IA; alerta inmediata al responsable cuando aparece un detractor, con el caso y su historia; tablero de dirección con NPS, ausentismo, tiempos de respuesta y volumen por canal.

IMPACTO Casos recuperados antes de escalar a queja pública; decisiones basadas en datos frescos. *Métricas: NPS por sede, % de detractores contactados en <24 hs.*

PLAN

5. Hoja de ruta: primeros 90 días

FASE	SEMANAS	QUÉ SE HACE	ENTREGABLE MEDIBLE
Discovery	1–2	Shadowing en call center y sedes; mapa real de sistemas y puntos de integración; línea base de métricas.	Mapa de procesos + métricas base acordadas.
Quick wins	3–6	P1 en una sede piloto; P2 alimentando la consola del call center.	Ausentismo del piloto vs. línea base.
Escalado	7–10	P3 en piloto controlado con derivación supervisada; P4 para laboratorio.	% de gestiones sin operador; tiempo informe → notificación.
Consolidación	11–13	P5 y P6; extensión de pilotos exitosos al resto de las sedes.	Tablero operativo en uso; plan de rollout 2027.

Principios de trabajo

- **Integrar, no reemplazar:** todo se construye sobre los sistemas existentes, vía API y eventos. Cero migraciones forzadas.
- **Humano en el circuito:** la IA resuelve lo repetitivo; las decisiones clínicas y los casos sensibles siempre llegan a una persona.
- **Datos de salud con máximo cuidado:** Ley 25.326 (datos sensibles), acceso mínimo necesario, trazabilidad de cada automatización.
- **Medir antes y después:** cada iniciativa arranca con línea base y se juzga por su métrica, no por la demo.

Quién lo propone: trabajo diseñando automatizaciones de procesos con **n8n** y desarrollo asistido por IA con **Claude**, con proyectos entregados desde chatbots con integración a sistemas de gestión hasta circuitos completos de onboarding. Mi enfoque es el de este documento: entender el proceso primero, automatizar lo que se repite, medir el resultado.

Nota metodológica: análisis elaborado exclusivamente con información pública (sitio y portal de DIM, tiendas de aplicaciones, plataformas de reclamos, prensa y redes) en julio de 2026. Los diagnósticos son hipótesis a validar con el equipo de DIM; los benchmarks corresponden al sector salud argentino, no a mediciones internas de la institución.